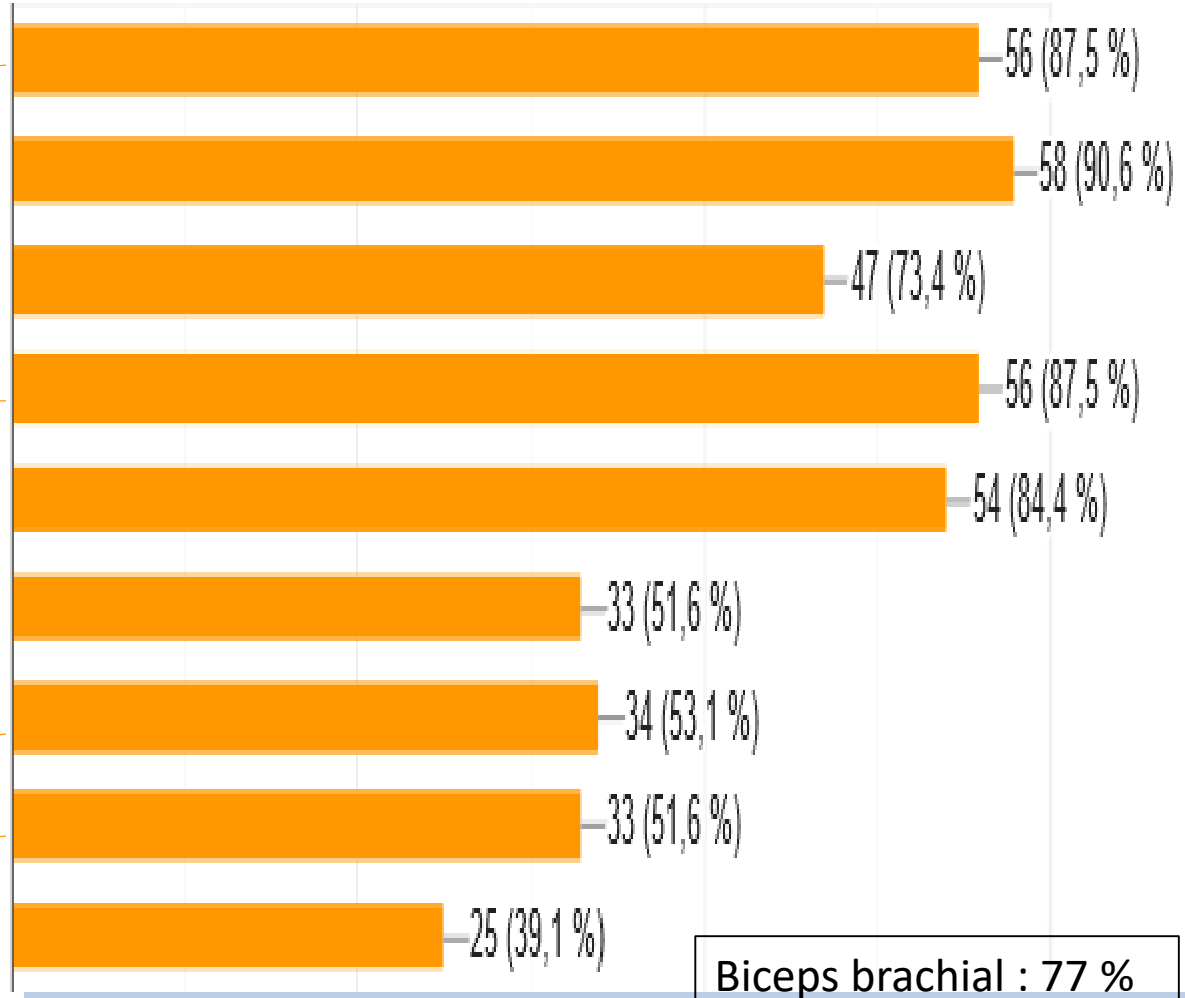
ECOS Examen clinique: Commentaires

Dr L.GILARDIN
MCUPH Médecine Interne
Hôpital Jean verdier, Bondy, APHP

Réalisation Testing: résultats

APTITUDES TECHNIQUES : RÉALISATION DU TESTING

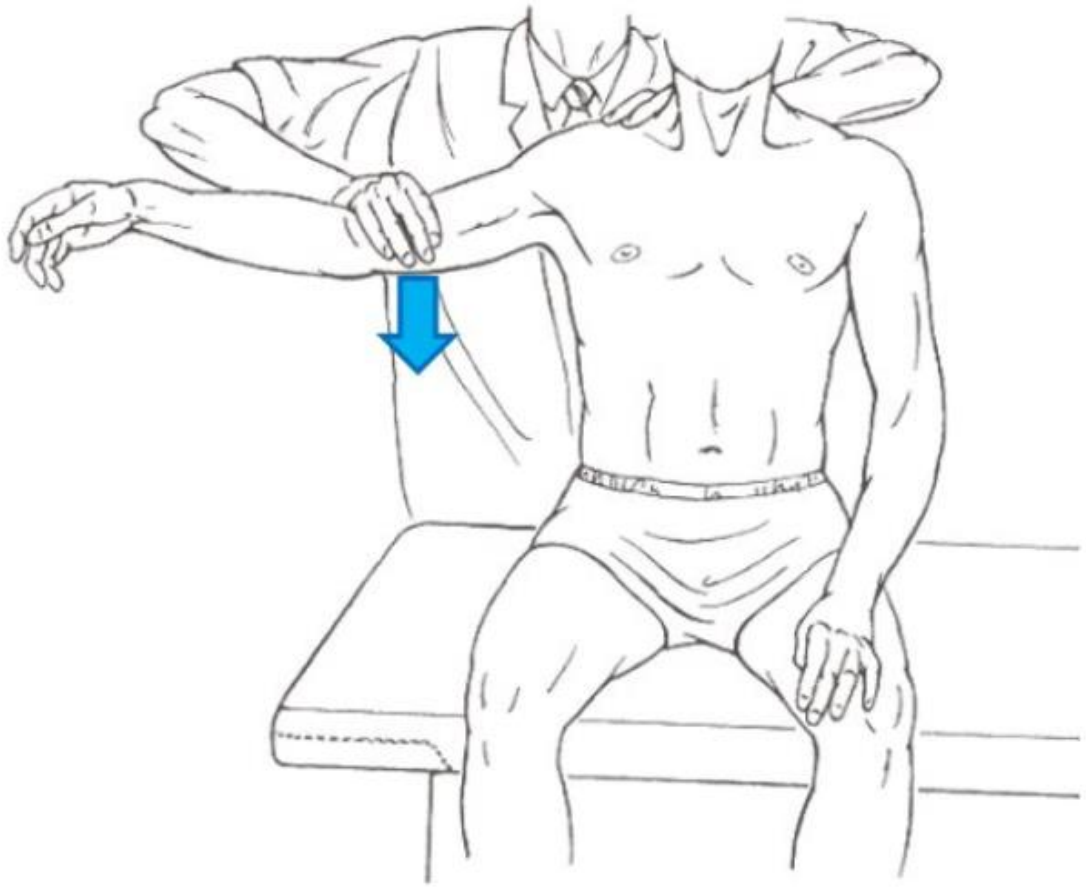
- ☐ L'étudiant·e met de la SHA en entrant dans la pièce
- ☐ L'étudiant·e se présente de manière complète (nom et fonction)
- ☐ L'étudiant·e recueille le consentement du /de la patient·e avant de procéder au testing
- ☐ L'étudiant·e réalise le testing une articulation à la fois
- ☐ L'étudiant·e réalise le testing de manière comparative (même articulation d'un côté puis de l'autre, et PAS tout un coté puis tout l'autre)
- ☐ L'étudiant·e n'oppose pas de résistance immédiatement mais laisse faire une amplitude complète PUIS fait opposition (surtout pour fléchisseurs/extenseurs du poignet)
- ☐ Manœuvre correcte pour le deltoïde moyen
- ☐ Manœuvre correcte pour les extenseurs du poignet
- ☐ Manœuvre correcte pour les fléchisseurs du poignet
- ☐ L'étudiant·e calcule correctement le total du score (51+51+10 = 112/130) **(annulée)**



Biceps brachial : 77 %

- Position de départ : membre sup. le long du corps.
- Le patient lève le membre sup. (plan frontal).
- Idéalement on laisse le patient lever le membre sup. jusqu'à l'horizontale (90°) et seulement après on applique une résistance vers le bas, au-dessus du coude.

Deltoïde moyen (abduction d'épaule)



- Position de départ : avant-bras posé sur la table, en supination (paume vers le haut).

- Le patient lève l'avant-bras (plan sagittal).

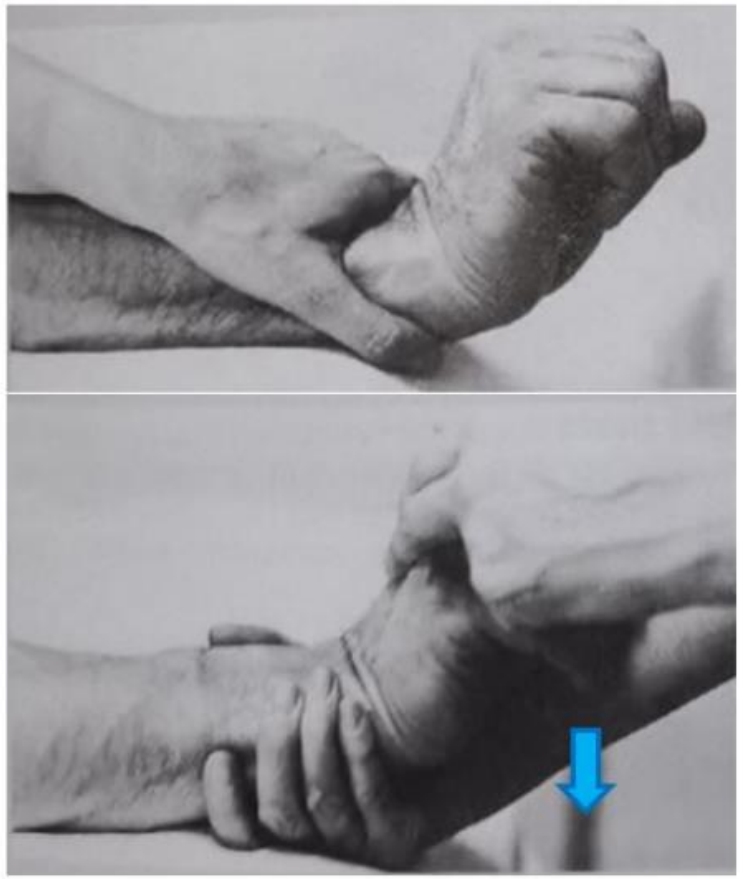
- Idéalement on laisse le patient lever l'avant-bras jusque ≥ 45° et seulement après on applique une résistance an ramenant le poignet vers le bas.

- Idéalement, on palpe les tendons du pli du coude (du brachioradial et du biceps brachial).

Biceps brachial (flexion du coude)

- Position de départ : avant-bras maintenu sur la table, en pronation (paume vers le bas), la main dépasse en dehors de la table.
- Idéalement on laisse le patient lever (étendre) la main (amplitude maximale) et seulement après on applique une résistance vers le bas.

Extenseurs du carpe (extension du poignet)



- Position de départ : avant-bras maintenu sur la table, en supination (paume vers le haut), la main dépasse en dehors de la table.
- Idéalement on laisse le patient lever (fléchir) la main (amplitude maximale) et seulement après on applique une résistance vers le bas.

Fléchisseurs du carpe (flexion du poignet)

Interprétations - Explications

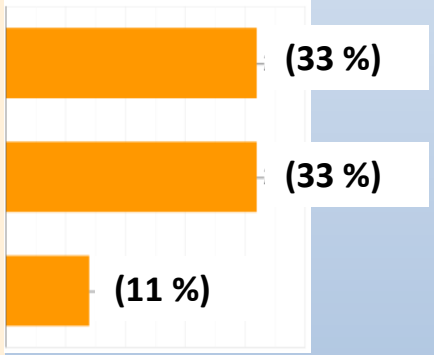
L'étudiant·e explique que la force musculaire est diminuée

- ◯ « Résultat anormal » sans précision spontanée
- ◯ « Diminution de la force musculaire »

EXPLICATIONS DONNÉES

- ☐ L'étudiant·e explique que l'altération de la force musculaire n'est pas due à la fracture / à l'immobilisation
- ☐ L'étudiant·e justifie sa conclusion, justification 1 : atteinte bilatérale et d'autres groupes musculaires
- ☐ L'étudiant·e justifie sa conclusion, justification 2 : aggravation dans le temps

Non fait : 23 %
« résultat anormal » : 20 %
Précisions données : 57 %



L'étudiant·e explique qu'il s'agit plus probablement d'une maladie neurologique et que l'obtention d'un diagnostic de certitude va nécessiter des explorations complémentaires

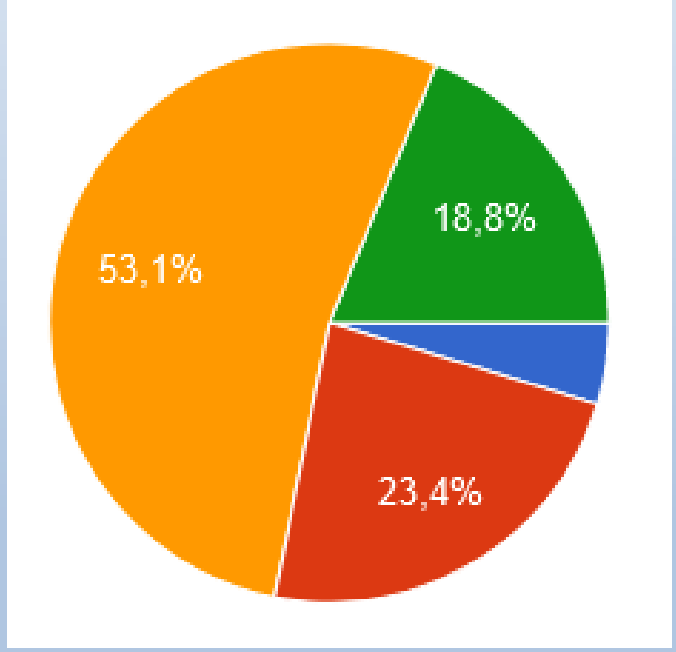
- ◯ Explications partielles ou imprécises
- ◯ Explications complètes et exactes

Non fait : 71 %
Partiel/imprécis : 27 %
Complet/exact : 2 %

Communication globale

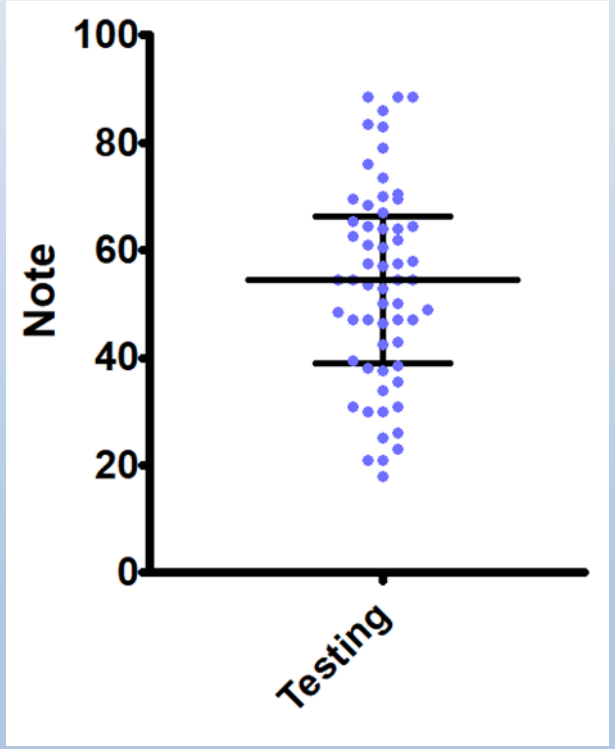
COMMUNICATION GLOBALE *

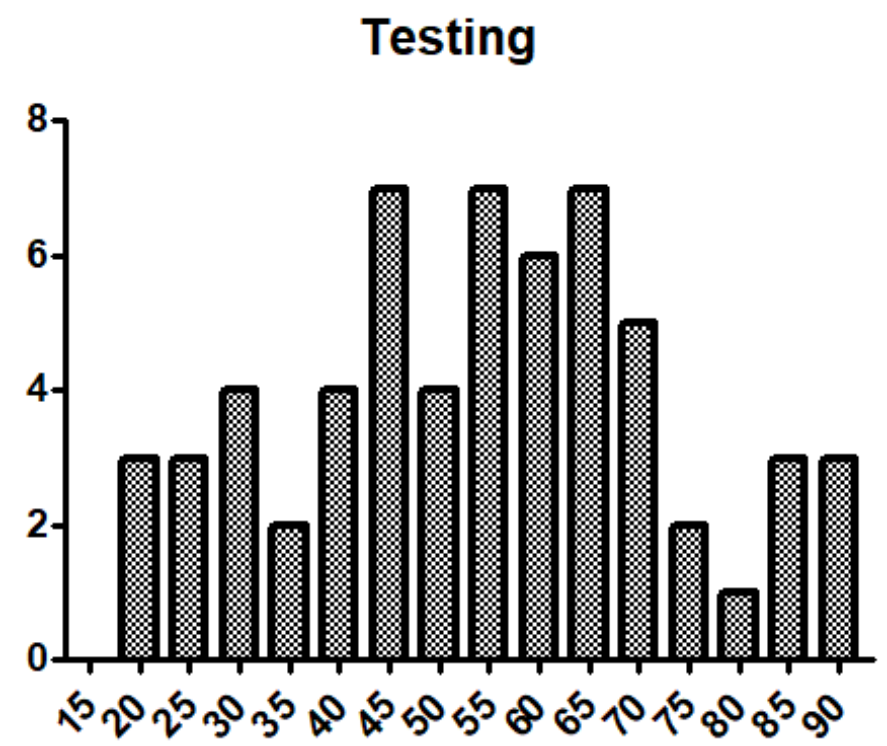
- Emploi de jargon médical ; Langage non verbal inadapté (ne regarde pas dans les yeux, rires, grimaces…)
- Quelques termes ou tournures maladroites ; Langage non verbal perfectible (regard fuyant…)
- Langage adapté mais pas de reformulation, ne demande pas si le/la patient·e a compris ; Langage non verbal adapté
- S'assure de la bonne compréhension, fait reformuler, repose la même question de deux manières différentes ; Langage non verbal adapté



Résultats

54 ± 19





Conseils

- On ne fait pas un examen clinique sans :
  - Recueillir le consentement du/de la patient·e
  - Sans lui expliquer ce qu'on en attend
  - Sans lui expliquer ce qu'on a trouvé + les implications

(valable aussi pour les examens complémentaires)

- La SHA n'est pas forcément nécessaire pour les stations d'entretien, mais indispensable en cas d'examen clinique +++
- Que ça ne vous "empêche" par de vous présenter de manière complète !